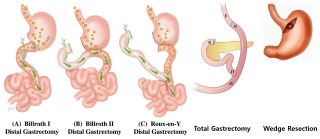
기생충
1. 충체가 보인다면 걍 내시경으로 제거하면 된다.

농양 치루 치열 치핵
1. 항문농양은 배농하면 끝이지만, 항문농양이 샛길을 만들면 샛길절제술/세톤을 해야하고, 이를 치루라고 따로 부른다.
2. 통증이 심한건 외치핵이다. 탈항은 통증이 없다.
3. 치열은 6주 기준으로 좌욕/완하제 쓸건지, 가쪽.속. 조임근절제술 할건지 나눈다.
4. 항문암은 절제하지 않는다.

@TNM_위암vs대장암
1. 위암/대장암 모두 점막하층/고유근층/장막하층이 T1/2/3임을 외우면 약간 더 좋다.

@위절제술／재건술의 종류
위암:



1. **Billroth I 위-샘창자 연결술**: 원위부절제술 이후 가장 선호하는 재건술(샘창자를 통과하므로 샘창자 흡수장애가 안생기는 장점)
2. **Billroth II 위-빈창자 연결술**: 위-샘창자 연결하기 너무 멀 때 대체적으로 시행, 담즙이 위로 들어가기 쉬워서 담즙역류성위염/들창자증후군이 생긴다.
3. **루엔와이 위-빈창자 연결술**: 사실 Billroth I도 구조적으로 담즙역류 가능한데, 나는 담즙역류가 너무너무 싫다 하는 환자일 때 시행. 다만 샘창자를 통과안하는 단점.
4. 전절제술: 저장공간이 사라져서 덤핑증후군 심하고, 위벽세포도 없으니 흡수장애 심함.
5. 쐐기절제술: GIST에서만 씀.

비만 & 역류성 식도염:



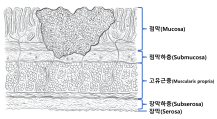
1. 루엔와이 위우회술: **고도비만(+) GERD(+)** 에서 시행
2. 소매절제술: **고도비만(+) GERD(-)** 에서 시행
3. 위바닥주름술: **고도비만(-) GERD(+)** 에서 시행

1. 그림보면 Y자 임을 알 수 있다.

대장암_①진단
1. 답이 무조건 대장내시경이 아니라, DRE나 CT일 수도 있다.

대장암_②절제술 선택+다운사이징 여부
1. 직장암은 다운사이징(neoadjuvant)를 시행하지만, 결장암은 하지 않는다.
2. 직장암의 다운사이징은 장막하층 침범을 기준으로 결정한다.
3. 직장암의 절제술 선택(복회음vs저위전방)은 항문연 5cm을 기준으로 결정한다.

대장암_③완치기준
1. 용종절제 후, 침윤깊이 점막하층 1000μm(1mm)이하면 수술 안해도 된다.
2. 수술절제 후, 침윤깊이 장막하층 이하면 화학요법 안해도 된다.

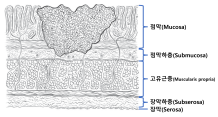


대장암_④폐색／전이
1. 폐색이 발생하면, 전이가 없어도 수술전까지 스텐트를 삽입한다.
2. 대장암환자에서 복수가 있다면 복막전이를 의심하여 복막 생검을 해야한다.
3. 대장암이 전이돼버렸다면 당연히 화학요법을 해야한다.
4. 단, 간/폐에 단일병변만 전이됐다면 수술로 해결할 수 있다.

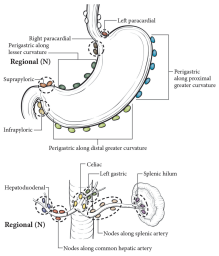
대장암_기타
1. FAP는 전대장절제술 후 회장-항문문합술하는 반면, 린치증후군은 전결장절제술 후 회장-직장문합술 한다. 직장을 보존한다는 얘기이다.

위암_①진단+절제술 선택
1. 내시경으로 위암을 발견했다면, 조직검사/CT/내시경초음파 를 시행한다.
2. 원위부 위암은 부분절제술이 가능하다.

위암_②완치기준
1. 용종절제 후, 침윤깊이 점막 이하/크기 2cm 이하면 수술 안해도 된다.
2. 수술절제 후, 침윤깊이 고유근층 이하면 화학요법 안해도 된다.



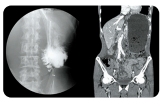
위암_③폐색／전이
1. 영역림프절 전이는 N stage, 원격림프절 전이는 M stage이며, 위의 영역림프절은 아래와 같다.



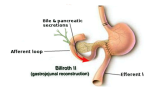
2. 영역림프절 전이와 달리, 원격장기/원격림프절 전이는 수술 못한다.
3. 폐색은 원위부 위암 때문에 발생하는데, 수술 못한다면 고식적 스텐트/위빈창자연결술 시행한다.
4. 원위부절제술 이후에 재발하면 전절제술 시행한다.

위암_④GIST vs 림프종
1. GIST는 점막하층만 증식해서, 점막 생검에서 정상으로 나올 수 있다.
2. GIST는 체부/저부에서는 쐐기절제술을, 원위부에서는 원위부절제술을 시행한다.
3. 위 림프종은 림프종 증상을 보인다.
4. 위 림프종은 암이지만 화학요법/수술을 하지않고, 제균치료 or 방사선요법을 시행한다.

위암_⑤술후 합병증
1. 문합술이니까 당연히 문합부 누출/출혈이 있을 수 있다.
2. 위가 빵빵해지는건 미주신경절제 때문일 수도 있고, 날창자폐색(날창자증후군) 때문일 수도 있다.



3. 들창자(십이지장)의 담즙이 위로 역류해서 위염도 발생하고, 구토도 발생한다.(들창자 증후군)



4. 저장공간이 작아지니 음식물이 너무 빨리 비워져서, 식후 구토설사/저혈당이 발생하는걸 후기덤핑증후군이라고 한다. 조금씩 자주먹어야 한다.
5. 철분과 vit B12 (코발아민) 흡수장애가 생겨서 빈혈이 발생한다.

위암_기타
1. 미분화형(Undiff)에 저분화(Poorly diff)도 있고 반지세포암도 있다.
2. 위암_②완치기준 대로 풀면 된다.
3. 참고로 위의 반지세포암이 난소로 전이된걸 Krukenberg tumor라고 한다.

곁주머니염 vs 곁주머니출혈
1. 곁주머니 자체는 무증상일 수 있다.
2. 염증이 발생하면 증상이 심하며, 시프로니다졸을 준다
3. 출혈이 발생하면 무증상혈변이 특이적이며, 지혈술을 한다.

압배
1. CT사진을 보고 어느게 그냥 압배고, 어느게 농양인지 구별해야 한다.

과민대장증후군
1. 표현형은 다양(설사/변비/복통)하지만, 긴장유발/변후완화가 특이적이다.
2. 진단이 너무 쉬운 대신, 약물 이름을 다 외워야 한다.
   - 설사 → 로페라미드, 5-HT3 길항제(라모세트론)
   - 변비 → 완하제
     - 메틸.셀룰로오스/차전자씨
     - 락툴로스/폴리에틸렌글리콜/마그네슘
     - 비사코딜/센나/도큐세이트
     - 프루칼로프라이드/루비프로스톤/리나클로티드/플레카나티드
   - 복통 → 진경제(트리메부틴, 티로프라미드, 피나베리움)

급성설사≈급성위창자염
1. 황색포도알균/B.cereus는 n시간(+) 수양성(+) 잠혈(-) 이며, 항생제가 전혀 필요없다.
2. 캄필로/살모/장출혈대장균은 n일(+) 점액성(±)[1] 잠혈(+) 이며, 수분공급후에 Cipro/Azi를 쓴다.
3. 설사로 온 소아에서, 모유/경구수액을 맥일지, 정맥주사를 꽂을지 결정해야한다. 먹지않으려하거나 바이탈이 흔들리면 정주하는건 당연한건데, 체중감소≥10% 일때도 IV적응증임을 알아야한다. 이때 줘야하는 수액량도 외워야한다.
   - 처음 1시간동안 투여해야할 수액량은? → *원래체중* × 20 (e.g. 10kg → 200mL)
   - 24시간 동안 투여해야할 수액량은? → *원래체중* × 100 + *잃은체중* + *계속소실량* (e.g. 6kg→5.4kg 이면 600+600+계속소실량)
4. 거짓막대장염은 경증에선 PO반코 or PO피닥소를 쓰고, 중증에선 PO반코+IV메트로 를 쓴다.

1. 초기에는 수양성으로 시작해서 점액성으로 진행한다.

기능성 소화불량(더부룩)
1. 그냥 "식후 더부룩"이 100% 특이도이다. 다만 의외로 명치통증도 흔하게 동반되기 때문에, 역류성 식도염과 헷갈리지만 않으면 되고, 긴장유발/변후완화가 없는 것을 꼭 확인하고 과민대장증후군과 헷갈리지만 않으면 된다.

만성설사
1. 혈변(-) 긴장유발/변후완화(-)인 만성설사는 대부분 흡수장애 때문에 생긴 것이다.
2. 금식을 해서 멈췄다면 환자가 먹었던 물질 때문일 가능성이 높다.
3. 지방성 설사였다면, 췌장부전이나 소장세균과다증식을 의심하며, 소장세균과다증식은 수소날숨검사로 진단하여 리팍시민으로 치료한다.
4. 담낭이 사라지면 담즙 보관이 안되고 줄줄나와 담즙성 설사가 발생한다.
5. 돌창자가 사라지면 담즙 재흡수가 안되고 남은 담즙이 대장으로 넘어가 담즙성 설사가 발생한다.

변비
1. 1차성 변비에서 서행성/골반저기능장애/직장류 3개가 제일 중요하다.
2. 1차성이니까 치료는 당연히 생활교정/완화제 이지만, 골반저기능장애에선 바이오피드백이 중요한 치료임을 알면 된다.
3. 어떤게 검사 이상인지 알아야 한다.
   1. 대장통과시간검사: 40시간 후에도 표지자가 남아있으면 이상인데, 이때 표지자 분포가 중요
   2. 풍선배출검사: 60초 이상 걸리면 이상
   3. 내압검사: 직장압과 항문압이 비례하면 이상

삼킴곤란
1. 삼킴곤란에는 구강 삼킴곤란, 구인두 삼킴곤란, 식도 삼킴곤란이 있다.



2. 구인두 삼킴곤란은 후두내시경→비디오투시삼킴검사로 진단하며, 재활치료 한다.
3. 식도 삼킴곤란에는 식도이완불능/식도연축/식도암이 있다.
4. 식도이완불능은 식도조영술→내압검사로 진단하며, 풍선확장/근절개/보톡스로 치료한다.
5. 식도이완불능과 식도암은 진행초기에 물을 삼키기 어려웠는지로 감별할 수 있다.

식도염

1. 식도내시경 사진과, 면역저하 여부를 보고, 칸디다/호산구/알약/단순포진 식도염을 감별할 수 있어야 한다.

역류성 식도염

1. GERD가 일상적이고 쉬운 질환 같아 보이지만, PPI 검사→내시경→24시간 산도검사 순이라는 것과, PPI 불응성이면 열공탈장 가능성을 꼭 염두에 두어야한다는 것이 어렵다.

소화성궤양_비출혈

1. 위암처럼 위궤양은 내시경상 궤양이 보이는 것으로 진단한다.
2. 궤양을 찾았다면 헬리코박터 여부를 파악하여, 위산억제제만 쓸지, 제균치료를 병합할지 결정해야 한다.
3. 현성출혈이 아니라면 아스피린을 끊을 필요 없다.[1]

1. 엄밀히는 forrest classification을 따르는데, 알 필요 없을듯

소화성궤양_천공

1. 윗배의 반동압통/과다굳음에서 소화성궤양_천공을 의심해야하며, CXR→옆누움CXR→CT 로 검사하여, 일차봉합술+그물막고정술로 치료한다.

소화성궤양_폐색

1. 위궤양을 n년 방치하면 날문협착이 생길 수 있고, 비위관→풍선확장→날문방절제술 로 치료한다.

위창간동 증후군

1. 장폐색이랑 다르게, 위폐색은 기껏해봐야 위궤양이나 위암인데, 위궤양 폐색은 대부분 날문부여서 비담즙성 구토니까, 샘창자암이 담즙성구토를 일으키겠지?
2. 그래서 위폐색(+) 담즙성(+)이면 위암을 보통 의심하지만, 희귀하게 위창간동이 샘창자를 누르는 증후군 때문일 수도 있다. CT로 보면 샘창자가 SMA에 눌린 것이 보인다. 위암을 배제하기 위해 내시경도 같이 해준다.

기계적 장폐색

1. 복부팽만(+) 구토(+) 장빵빵(+) 이면 장폐색이니 금식/수액/비위관으로 대처한다.
2. 환자가 교액 증상을 보이진 않는지 꼭 배제한다.
3. 그 다음 CT를 찍고 장의 구조적 상태에 따라 스텐트/절제술/감압술을 결정한다.

기계적 장폐색 (Mechanical obstruction)	마비성 장폐색≈거짓막힘(Paralytic ileus)
복통(+) 구토(±)	복통(-) 구토(±)
장음 증가했다가 점차 감소	항상 감소
금식/수액투여/비위관 삽입	금식/수액투여/비위관 삽입
교액[1] → 항생제[2]+응급 개복술 대장암 → 내시경스텐트 장중첩증 → 부분절제술 구불창자꼬임 → 내시경 감압술	수술하지 않음

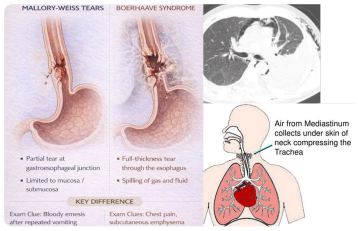
1. 반동압통이 없어도 ↑4대 염증수치 있으면 교액을 골라야 하는 문제도 2번 출제되었다.
2. 세파니다졸 이건 출제된 적 없고 몰라도 될듯.

마비성 장폐색≈거짓막힘

1. 대장의 연동운동이 느려진 정도에 따라서 변비→마비성 장폐색(거짓막힘)→거대결장이 생길 수 있다.
2. 연동운동이 느려지는 이유는 특발성/컨디션악화/칼륨/갑상선/약물/신경 등이 있다.
3. 연동운동이 느려진 이유가 명확하면 그걸 치료하면 되고, 아니면 대증치료를 하면 되는데, 변비급이면 완하제 주면되고, 장폐색급이면 금식/수액/비위관 하면 된다.

말로리바이스 vs Boerhaave

1. 식도내 압력이 높아지면 식도가 찢어지는데, 적당히 찢어지면 말로리바이스, 터지면(천공) 보어하베 증후군이 된다.



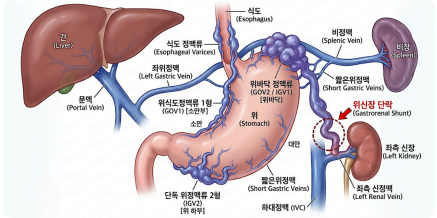
2. 말로리는 토혈이 심하지만, 보어하베는 피/공기가 모두 종격동으로 새어나가서 토혈은 덜할 수 있고, 종격동기종→피하기종→비빔소리 가 특이적이다.
3. 둘 다 심각한 질환이지만, 막상 말로리도 현성출혈(-) 면 경과관찰하고, 보어하베도 혈역학적 불안정(-)면 수술 안한다.

소화성궤양_출혈

1. 위궤양이 현성출혈이라면 내시경지혈술을 하고, PPI를 IV로 줘야한다.
2. 이거 실패하면 색전술한다.

정맥류

1. 정맥류환자가 오면 바이탈 잡고, 내시경지혈술 하면 되는데, 이때 내시경지혈술의 선택이 정맥류위치(식도/위/위바닥)에 따라 다르다. 식도는 점막이 하늘하늘해서 고무줄로 묶고나오기 너무 좋은 반면, 위바닥은 점막이 탱탱해서 시아노아크릴 주입해서 경화시키는게 좋다. 위는 둘다 가능.
   - 

   - 식도 → 묶음술(결찰술)
   - 위바닥 → 경화술(폐색술) or TIPS/RTO
   - 위 → 경화술 > 묶음술
2. 내시경 지혈에 실패하면 당연히 내시경이 아닌 방법(TIPS/RTO)를 써야하는데, RTO는 식도정맥류 금기(위-신 단락을 막는 시술인데, 애초에 식도정맥류는 위-신 단락과 노상관임)이고, TIPS는 간성혼수 금기이다.
   - 

3. 내시경/TIPS/RTO등 시술을 준비하기 전, 임시방편으로 S-B tube로 압박지혈을 해놓는다.

토혈 내원시 내시경 선택

1. 토혈/흑색변 있으면 식도위내시경 시행하며, 예외는 2개밖에 없다.
   1. 비빔소리(염발음) 등 천공이 의심되면 내시경 금기니 영상검사로 대체한다.
   2. 술후토혈(e.g. 며칠전 위암수술 받았는데 토혈) 이면 내시경이 아니라 응급수술을 해야한다.
2. 혈역학적 불안정은 내시경의 금기가 아니며, 오히려 빨리 내시경지혈술을 해야하는 상황이다.

혈관형성이상 vs 듀라포이

1. 위궤양/정맥류/말로리 셋다 아니라면 혈관형성이상/듀라포이를 반드시 의심해야하며, 사진보고 구별할 수 있어야 한다.

CROHN vs UC

1. CROHN
   - CobbleSkip (종주성궤양)
   - Rectal sparing / Rt. pain → UC는 5-ASA/스테로이드를 관장/좌약 하기도 하지만 CROHN은 한참 멀어서 불가능
   - Obstruction → 조금만 먹어도 배부름/구역→체중감소
   - Hangmun 농양
   - Non-caseous granuloma → 치즈육아종일 경우엔 장결핵→항결핵제
2. UC
   - Um 비틀림
   - Count ≤4, ℃(-)
3. 5-ASA→스테로이드→anti TNF-α→장절제술 순서로 치료한다.
   - "오스 알파메일의 장절제술"
4. 5-ASA 적응증(스테로이드까지 안써도 되는 기준)을 외워야 한다.
   - CROHN: **심한 체중감소(-), 항문농양(-)**
   - UC: **배변횟수≤4, 발열(-)**
5. 영양처방이 다르다.
   - CROHN: 경장영양(장관영양) or TPN
   - UC: 경구 고칼로리 식사
6. 약을 몇년 동안 쓰는데도 괴로움 극심하면 수술을 고려한다.
   - CROHN → 부분절제 (Rectal sparing)
   - UC → 전절제

기타 비감염 장염

1. CROHN/UC도 아니고 감염도 아닌 장염이 꽤 많다.
2. CMV 장염은 봉입체 발견되며, UC에서 흔하고, 간시클로버로 치료한다.
3. 방사선 장염(모세혈관확장증)은 방사선요법 이후 발생하며, 로페라미드로 치료한다.
4. 호산구성 장염은 호산구침윤, 현미경적(미세)장염은 림프구침윤이 제시되며, 치료는 둘 다 스테로이드이다.
5. 소아의 알레르기직장결장염도 호산구침윤인데, 치료는 환모의 항원제한식이로 다르다.
6. 허혈성 장염은 혈압만 안좋은 거라 수액투여하고 경과관찰한다.

허혈성대장염 vs 장간막허혈

1. 허혈성대장염은 고령에서 혈압약 등으로 일시적 저혈압이 발생했을때, watershed area(왼쪽)에 허혈이 발생해 혈변_설사가 생기며, CT/내시경으로 진단하고 그냥 수액만 주면 된다.
2. 장간막허혈은 위창간동혈전이랑 똑같은 말이고, 지체하면 장 다 썩으니 얼른 혈전을 빼내줘야 한다.

혈변 내원시 내시경 선택

1. 혈압>90이면 구불결장내시경(40대부턴 대장) → 실패시 캡슐내시경
2. 혈압<90이면 식도위내시경 → 실패시 혈관조영술
3. 단, NSAID 복용력 있으면 혈압>90이어도 위궤양 뻔하니 식도위내시경